

מדריך מפורט להגשת תביעה לגמלת סיעוד

מדריך מעשי למשפחה — מה מגישים, מה לבקש מהרופאים, ומה לומר למעריך בביקור הבית

1. תנאי סף לזכאות ומסמכים נדרשים

א. תנאי סף לזכאות

- **גיל ותושבות:** תושב/ת ישראל שהגיע/ה לגיל פרישה.
- **מגורים:** מתגורר/ת בבית, בדיר מוגן, או במחלקה לעצמאיים/תשושים בלבד (אדם במחלקה סיעודית או לתשושי נפש בבית אבות מורשה אינו זכאי לגמלה זו).
- **מבחן הכנסות (מעודכן ל-2026)**
 - **יחיד:** הכנסה עד 13,769 ש"ח — גמלה מלאה; מ-13,769 עד 20,654 ש"ח — גמלה מופחתת (50%); מעל 20,654 ש"ח — אין זכאות.
 - **זוג:** הכנסה עד 20,654 ש"ח — גמלה מלאה; מ-20,654 עד 30,980 ש"ח — גמלה מופחתת (50%); מעל 30,980 ש"ח — אין זכאות.
 - (אם שני בני הזוג סיעודיים — סכום הכנסותיהם המשותף מחולק ב-2 ונבחן לפי תקרת יחיד).
- **אי-קבלת קצבאות חופפות:** אינו מקבל קצבת שירותים מיוחדים (שר"ם), קצבת עזרת הזולת ממשד הביטחון או תשלום מקביל.

ב. אילו מסמכים לצרף לתביעה?

- **טופס תביעה לגמלת סיעוד (טופס 2600):** למילוי מקוון או ידני.
- **תמצית תיק רפואי (סיכום מידע רפואי ממוחשב):** חתום על ידי רופא המשפחה.
- **אבחונים ייעודיים (לפי הצורך)**
 - **ירידה קוגניטיבית / דמנציה:** הערכה גריאטרית או פסיכוגריאטרית כולל מבחן MMSE (מיני-מנטל).
 - **ליקוי ראייה:** חוות דעת מרופא עיניים.
- **אישורי הכנסה:** תלושי פנסיה ואישורי הכנסה של המבוטח/ת ובן/בת הזוג מ-3 החודשים האחרונים.

2. מה לבקש מהרופאים לכתוב במסמכים הרפואיים

עיקרון מנחה

הביטוח הלאומי קובע את רמת הזכאות על סמך "מבחן תלות" הבודק תפקוד יומיומי בפועל — ולכן חשוב שהמסמכים הרפואיים לא יסתפקו באבחנה הרפואית עצמה, אלא יתארו כיצד האבחנה באה לידי ביטוי בתפקוד היום-יומי בבית.

מה חשוב לבקש שיודגש במסמכים

- **תפקוד יום-יום (ADL):** לבקש מהרופא לפרט במדויק את הקשיים ברחצה, הלבשה, אכילה, ניידות בבית, ושליטה על סוגרים — ולא להסתפק בניסוח כללי כמו "מוגבלות בתפקוד".
- **צרכי השגחה ובטיחות:** אם קיים אובדן זיכרון, שיפוט לקוי, סכנה בשימוש בגז/חשמל או סכנת נפילה — יש לבקש מהרופא להדגיש זאת במפורש, שכן זהו נתון מרכזי לקביעת ניקוד ההשגחה (ראו פרק 3 להלן).
- **תיעוד נפילות:** לבקש מהרופא לציין מספר, נסיבות ותדירות נפילות ב-3 החודשים האחרונים, ואופן הקימה מנפילה — נתון זה משפיע הן על ניקוד הניידות והן על ניקוד ההשגחה.

- **הפניה לאבחונים ייעודיים:** במקרה של ירידה קוגניטיבית — לבקש הפניה להערכה גריאטרית/פסיכוגריאטרית הכוללת מבחן MMSE; במקרה של ליקוי ראייה משמעותי — לבקש חוות דעת מרופא עיניים.

טיפ מעשי למשפחה:

- להגיע לרופא עם רשימה כתובה מראש של הקשיים בפועל בכל תחומי היום-יום (לפי הפרקים בהמשך המדריך).
- לבקש מהרופא לשלב בדוח דוגמאות קונקרטיות מהיומיום, ולא רק ניסוח רפואי כללי.

3. מבחן התלות — כך נקבע ניקוד הזכאות

רקע כללי

קביעת רמת הזכאות לגמלת סיעוד מתבססת על "מבחן תלות" (הערכה תפקודית), שמטרתו לאמוד את מידת תלותו של הנבדק בזולת בביצוע פעולות היום-יום, ואת מידת הזדקקותו להשגחה. ההערכה מתבצעת בביקור בית על ידי מעריך מטעם המוסד לביטוח לאומי (אחות, פזיותרפיסט/ית או מרפא/ה בעיסוק), בהתאם לנהלים המפורטים ב"תדריך לביצוע הערכה תפקודית — ביטוח סיעוד" של אגף הסיעוד.

במסגרת המבחן נבדקות חמש פעולות יום-יום (ADL): ניידות, הלבשה, רחצה, אכילה ושתייה, והפרשות — וכן נבחנת בנפרד מידת הצורך בהשגחה. לכל תחום ניתן ניקוד בין תפקוד עצמאי (0 נקודות) לבין אי-יכולת ביצוע (1–2 נקודות, בהתאם לתחום הנבדק ולחומרת המגבלה). סכום הנקודות שנצבר קובע את רמת הזכאות (1 עד 6).

תחומי הבדיקה (ADL) וטווחי הניקוד

טווח ניקוד אפשרי	מה נבדק בפועל	תחום נבדק
0 (עצמאי) עד 2–1 נק' (בהתאם לרמת התלות)	קימה מהמיטה/מכיסא, הליכה, ישיבה, שימוש במכשירי עזר, התמצאות בחדרי הבית, מעבר לכיסא גלגלים	ניידות בבית
משפיע על מסקנת הניידות וההשגחה	מספר, נסיבות ותדירות נפילות ב-3 החודשים האחרונים ואופן הקימה מנפילה	נפילות
0 (עצמאי) עד 2–1 נק'	לבישה ופשיטה של בגד עליון ותחתון, גריבת גרביים, נעילת נעליים, הרכבת מכשיר אורתופדי	הלבשה
0 (עצמאי) עד 2–1 נק'	כניסה למקלחת/אמבטיה, רחיצת פנים וידיים כולל סבון וניגוב, חפיפת ראש	רחצה
0 (עצמאי) עד 2–1 נק'	חימום מנת מזון והגשתה לשולחן, אכילה בכף, מזיגה ושתייה מכוס, נטילת תרופות בעזרה פעילה	אכילה ושתייה
0 (עצמאי) עד 2–1 נק'	הגעה לשירותים, ישיבה וקימה מהאסלה, הפשלת/הרמת בגד תחתון, היגיינה אישית ושליטה בסוגרים	הפרשות

הערה: הניקוד המדויק לכל סעיף-משנה (למשל ניידות בבית לעומת הליכה בליווי, או הלבשת חצי גוף עליון לעומת תחתון) נקבע על פי טבלת ניקוד פנימית בטופס "הערכת התלות" של המוסד, שאינה מפורסמת במלואה כטבלה ציבורית באתר btl.gov.il. התדריך הציבורי מפרט את אופן ביצוע התצפית וההדגמה בכל תחום, אך לא את מפתח הניקוד המספרי המלא לכל תת-סעיף.

השגחה

בנוסף לסעיפי ה-ADL, נבדקת בנפרד מידת הצורך בהשגחה. הניקוד בגין השגחה אינו מצטבר עם ניקוד ה-ADL — הזכאות נקבעת לפי הניקוד הגבוה מבין השניים:

ניקוד	הגדרה	סוג השגחה
2.5 נק'	ניתן להשאיר את הנבדק לבד לפרקי זמן מסוימים, אך בהעדר השגחה עלול להגיע להזנחה קיצונית או חרדה משמעותית	השגחה חלקית
9 נק'	לא ניתן להשאיר את הנבדק לבד אף לפרקי זמן קצרים, בשל סכנה בלתי צפויה לעצמו או לאחרים	השגחה מתמדת

להלן טווחי הניקוד הרשמיים לכל רמת זכאות, כפי שמפורסמים בטופס בל/2655 של המוסד לביטוח לאומי ("בקשה לקבלת גמלה בכסף לזכאי גמלת סיעוד המעסיק מטפל צמוד"), לרבות היקף שעות הטיפול השבועיות. סכומי הגמלה בכסף בטבלה משקפים את הנתונים כפי שפורסמו במסמך המקור (מעודכנים לנובמבר 2018) והם משתנים מעת לעת — לסכומים העדכניים יש להיעזר במחשבון הסיעוד באתר המוסד.

סכום גמלה בכסף לדוגמה	שעות טיפול שבועיות (עובד זר)	שעות טיפול שבועיות (עובד ישראלי)	טווח נקודות בהערכת התלות	רמת זכאות
1,407 ₪	לא משפיע	5.5 – 9	2.5 – 3	1
2,047 ₪	לא משפיע	10	3.5 – 4.5	2
3,070 ₪	12	15	5 – 6	3
3,889 ₪	16	19	6.5 – 7.5	4
4,708 ₪	19	23	8 – 9	5
5,731 ₪	24	28	9.5 – 10.5	6

תוספות ניקוד נפוצות

- תוספת "בודד" — זכאי המוגדר כ"בודד" (בהתאם לסידורי המגורים ולנוכחות בני משפחה) זכאי לתוספת ניקוד: 0.5 נק' למי שצבר 2 נק', 1.5 נק' למי שצבר 2.5–5 נק', 0.5 נק' למי שצבר 6 נק', ו-1.5 נק' למי שצבר 6.5 נק' ומעלה.
- מי שנקבעו לו 6.5 נקודות ומעלה זכאי לתוספת ניקוד נוספת של 1.5 נקודות (בכפוף לתנאים).
- ניתן לעדכן ניקוד "בודד" גם לאחר ביצוע בדיקת התלות, על סמך הצהרה שיגיש הזכאי במקרה של שינוי במצב המשפחתי.

4. ביקור הערכת התפקוד בבית — מה לומר למעריך

מי מבצע את הבדיקה ומתי

- מי מקיים את הבדיקה?: מעריך/ה מטעם הביטוח הלאומי (אח/ות או פיזיותרפיסט/ית) המגיעים לבית.
- חלופה לבני 90 ומעלה: זכאים לבחור להיבדק על ידי רופא גריאטר בקופת החולים במקום ביקור בית.

כללי ברזל ליום הבדיקה

- חובת נוכחות מלווה: מומלץ מאוד שכן משפחה או אדם קרוב יהיה נוכח לכל אורך הבדיקה.
- שיקוף המציאות: קשישים רבים מנסים להפגין עצמאות מול הבודק. על המלווה להסביר בנעימות ובכבוד את הקשיים האמיתיים בשגרה (כגון נפילות, צורך בעזרה ברחצה, שכחת תרופות).
- בטיחות: אין לבצע מטלה שגורמת לכאב או מסכנת את המבוטח בנפילה.

מה חשוב להדגיש בכל תחום בדיקה

- ניידות בבית: לתאר קשיים בקימה מהמיטה/מכיסא, הליכה בבית, שימוש במכשירי עזר, ולציין נפילות ב-3 החודשים האחרונים — נסיבות, תדירות ואופן הקימה.
- הלבשה: לתאר קושי בלבישה ופשיטה של בגדים, גריבת גרביים, נעילת נעליים או הרכבת מכשיר אורתופדי.
- רחצה: לתאר קושי בכניסה למקלחת/אמבטיה, ברחיצת פנים וידיים, ובחפיפת ראש.
- אכילה ושתייה: לתאר קושי בחימום מזון והגשתו, באכילה ובשתייה עצמאית, ובנטילת תרופות.
- הפרשות: לתאר קושי בהגעה לשירותים, בישיבה וקימה מהאסלה, ובשליטה בסוגרים.

- **השגחה:** לתאר במפורש האם ניתן להשאיר את הנבדק לבד, ולציין סיכונים כמו שכחת גז/חשמל דלוק, שיטוט, או סכנת נפילה בהיעדר השגחה.

5. שירותי "טרומ סיעוד" (טרומ החלטה)

- **מה זה?:** אספקת שעות טיפול אישי בבית באופן מיידי (לרוב כ-6 שעות שבועיות), עוד לפני שהביטוח הלאומי סיים לעבד את התביעה ולקבל החלטה.
- **למי פונים?:** ישירות לחברות סיעוד פרטיות הפועלות בהסדר עם הביטוח הלאומי.
- **באילו מצבים?:** כאשר יש צורך דחוף בסיוע מיידי בבית (למשל, מיד לאחר אירוע רפואי, שחרור מבית חולים, או הידרדרות תפקודית פתאומית).
- **מהם הקריטריונים לקבלה?**
 - הוגשה תביעה לביטוח הלאומי (או בקשה להחמרה).
 - חברת הסיעוד בוחנת את המסמכים הרפואיים ומעריכה כי קיים סיכוי סביר שהתביעה תאושר בביטוח הלאומי.
- **עלות וקידוד:** השירות ניתן ללא תשלום. אם התביעה תאושר, השעות שניתנו יקוזזו רטרואקטיבית מגמלת הסיעוד שתאושר; אם התביעה תידחה, חברת הסיעוד היא זו שנושאת בעלות השירות ולא המבוטח.

6. הגשת בקשה לבדיקה מחדש עקב החמרת מצב

- **מי זכאי?:** מבוטח שכבר מקבל גמלת סיעוד (ברמות 1 עד 5) וחלה הידרדרות נוספת בתפקודו.
- **איך מגישים?:** באמצעות טופס 2620 (או בשליחת מסמכים מעודכנים בפורטל האישי).
- **אשפוז בבית חולים:** במידה וההחמרה התרחשה במהלך אשפוז, ניתן להגיש טופס 2668 מואץ דרך העובדת הסוציאלית של בית החולים.
- **עיתוי התשלום:** עדכון הדרגה והגמלה יחול בדרך כלל מהיום השמיני שלאחר מועד הגשת הבקשה להחמרה.

7. מצב אדם מאושפז שבקשתו אושרה בזמן השהות בבית החולים

- **30 הימים הראשונים:** מקבל גמלת סיעוד שמאושפז בבית חולים כללי זכאי להמשיך לקבל את שירותי הטיפול האישי (מטפלת) בבית החולים במהלך 30 הימים הראשונים לאשפוז.
- **סיוע מהעובדת הסוציאלית בבית החולים:** מומלץ להיעזר בעובדת הסוציאלית של המחלקה/בית החולים עוד במהלך האשפוז. היא יכולה לסייע בריכוז המסמכים, בהגשת פניות מוצאות לביטוח הלאומי (כגון טופס 2668) ובתיאום רצף הטיפול והזכויות לקראת השחרור הביתה.
- **מעל 30 ימים / אשפוז סיעודי:** מהיום ה-31 לאשפוז כללי (או מיום המעבר למחלקה סיעודית/סיעודית מורכבת/שיקומית), מתן השירותים מוקפא.
- **עם השחרור הביתה:** הזכאות מתחדשת מיד עם השחרור לבית, ללא צורך בהגשת תביעה חדשה. יש לעדכן את הביטוח הלאומי וחברת הסיעוד על מועד השחרור כדי להפעיל את השירות באופן מיידי.

8. לאחר שהבקשה אושרה — מימוש הזכויות

לאחר קבלת הודעת האישור והרמה שנפסקה (רמות 1–6):

- **בניית תכנית טיפול:** עו"ס מטעם הביטוח הלאומי או חברת הסיעוד יצרו קשר לבניית "סל שירותים" מותאם.
- **שעות טיפול אישי בבית:** מתן עזרה ברחצה, הלבשה, השגחה וניהול משק הבית.
- **המרה לקצבה בכסף (חשבון הבנק)**
 - ברמה 1: ניתן להמיר את כל הזכאות לקצבה כספית מלאה.
 - ברמות 2–6: ניתן להמיר חלק מהשעות (עד 4 שעות שבועיות, או עד שליש מהשעות באישור עו"ס) לקצבה כספית.

- מעסיקי מטפל צמוד (כולל עובד זר): מי שמעסיק מטפל צמוד כחוק רשאי לקבל את כל גמלת הסיעוד כקצבה בכסף ישירות לחשבון הבנק.
- **שילוב שירותים נוספים:** ביקור במרכז יום לקשיש (כולל הסעות וארוחות), אספקת מוצרי ספיגה עד הבית, לחצן מצוקה ושירותי כביסה.

9. תהליך הערעור על ההחלטה

קיימים שני מסלולים נפרדים לערעור על החלטת פקיד התביעות, בהתאם לסוג ההשגה:

ערעור בשאלה משפטית / הכנסות	השגה על מידת התלות / תפקוד	זמן הגשה
תוך 12 חודשים	תוך 60 יום מיום קבלת ההודעה	זמן הגשה
בית הדין האזורי לעבודה	ועדה מייעצת (רופא ואחות שאינם עובדי הביטוח הלאומי)	הגורם הדן
זכאות לייצוג משפטי חינם מטעם משרד המשפטים, ללא בדיקת הכנסות	הזכאות אינה יכולה להיפחת בעקבות ערר זה	הערה

דגש חשוב לערר על מידת התלות:

- מומלץ לציין במפורש בכתב הערר שברצונכם להופיע בנוכחות המבוטח ומלווה בפני הוועדה, ולא להסתפק בדיון על גבי מסמכים בלבד.

10. נושאים נוספים שחשוב להכיר

- **מסלול ירוק / בדיקה מהירה:** חולים במחלות קשות (כגון אונקולוגיה פעילה, ALS, אי ספיקת כליות בדיאליזה וכד') זכאים לטיפול מהיר ולקביעת זכאות על בסיס מסמכים רפואיים בלבד, ללא צורך בביקור בית.
- **זכאות מורחבת לניצולי שואה:** ניצולי שואה המקבלים גמלת סיעוד מביטוח לאומי ברמות 2–6 עשויים להיות זכאים לשעות סיעוד נוספות (עד 9 שעות שבועיות נוספות) הממומנות על ידי הקרן לרווחת נפגעי השואה.
- **כפילות זכויות — ביטוח סיעודי בקופות החולים:** קבלת גמלת סיעוד מהביטוח הלאומי אינה פוגעת בזכות להגיש תביעה מקבילה לביטוח הסיעודי הפרטי/קבוצתי דרך קופת החולים (כמו "כללית מושלם", "מכבי סיעודי" וכד') לקבלת פיצוי כספי חודשי נוסף.

נספח. נכה צה"ל שחוזה החמרה בתפקוד עקב גיל

כאשר נכה צה"ל החווה החמרה בתפקוד עקב גיל (או בשל בעיות רפואיות אחרות שאינן מוכרות כקשורות לנכות הצה"לית), מתקיים פיצול בסמכויות ובטיפול בין אגף השיקום במשרד הביטחון לבין המוסד לביטוח לאומי (ומערכת הבריאות/הרווחה האזרחית). להלן שלבי הפעולה והאפשרויות העומדות בפניו:

1. מיצוי זכויות במערכת האזרחית (המוסד לביטוח לאומי)

אגף השיקום במשרד הביטחון מעניק תגמולים ועזרת זולת רק עבור הנכויות שהוכרו במשרד הביטחון. כאשר התפקוד הידרדר בשל פגיעות או תהליכי הזיקנה הטבעיים שאינם מוכרים:

- **גמלת סיעוד מביטוח לאומי:** אם הגיע לגיל פרישה, הנכה זכאי להגיש תביעה לגמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי.
- **אין כפל קצבאות ישיר, אך יש הפרדה במענה:** ביטוח לאומי ומשרד הביטחון מוודאים שאין כפל תשלום על אותה הנכות, אך נכה צה"ל המקבל עזרת זולת ממשרד הביטחון עבור הנכות המוכרת, זכאי לקבל השלמה או גמלת סיעוד מביטוח לאומי עבור הירידה התפקודית הכללית שאינה קשורה לנכות המוכרת (בהתאם למבחן תפקוד/הערכת תלות — ADL).

2. בדיקת קשר סיבתי ("החמרה עקב הנכות המוכרת")

לפני שפונים למערכת האזרחית בלבד, מומלץ לבדוק מול רופא מומחה האם יש קשר עקיף בין ההידרדרות לבין הנכות המוכרת:

- **החמרה מוכרת:** לעיתים קרובות, נכות פיזית או נפשית מוכרת מאיצה או מחמירה בעיות תפקוד עקב הגיל (למשל: עקב עומס יתר על מפרקים בריאים, שימוש ממושך בתרופות, או עקב הירידה החסונית/תנועתית הכללית).
- **בקשה להחמרת מצב / הכרה בתקנה 9:** אם יש יסוד רפואי לכך שההידרדרות נובעת או מושפעת מהנכות המוכרת, ניתן להגיש בקשה לבדיקה חוזרת (החמרת מצב) לרופא המוסמך באגף השיקום, כדי להגדיל את היקף עזרת הזולת או את אחוזי הנכות.

3. סיוע משלים מאגף השיקום

אגף השיקום מכיר בכך שנכי צה"ל מתבגרים ומגיעים לגיל שלישי:

- **הערכה תפקודית כוללת:** מומלץ לפנות לעובד/ת הרווחה באגף השיקום (במחוז המטפל). העובד הסוציאלי יכול לבצע הערכה תפקודית כוללת ולבחון אילו מענים או התאמות ניתן לתת במסגרת מעטפת הטיפול של אגף השיקום (כגון ציוד עזר, שינויי דיור, או שילוב בין עזרת הזולת של משרד הביטחון לזכאויות אזרחיות).
- **טיפולים פרא-רפואיים ושיקום:** בדיקת זכאות להרחבת טיפולי פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק או הידרותרפיה דרך אגף השיקום לשימור התפקוד הקיים.

תכנית עבודה מומלצת

1. פנייה לרופא מטפל (משפחה/גריאטר): לקבלת הערכה תפקודית מקיפה וחוות דעת האם יש קשר לנכות המוכרת.
2. פנייה לעובד/ת הרווחה באגף השיקום: לבירור שילוב הזכויות והעברת התיק להערכה מעודכנת.
3. הגשת תביעה לגמלת סיעוד בביטוח לאומי: במידה והירידה התפקודית היא כללית ולא קשורה לנכות המוכרת.
4. התייעצות עם ארגון נכי צה"ל: לקבלת ליווי וסיוע במיצוי הזכויות מול שני הגופים (אגף השיקום וביטוח לאומי).

מקורות: מבוסס על נהלי המוסד לביטוח לאומי (btl.gov.il), טופס בל/2655, ותדריך אגף הסיעוד לביצוע הערכה תפקודית. מסמך זה נועד לשמש כחומר עזר מקצועי בלבד ואינו מהווה תחליף לבדיקה פרטנית של תיק התביעה או לייעוץ משפטי.